



Collection MedWIZ

1^{re} année médecine

SECOURISME

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Secourisme	6				
02	Obstruction des voies aériennes chez le conscient	8				
03	Patient inconscient : Respiration ou arrêt respiratoire	10				
04	Prise en charge des traumatismes	12				
05	Prise en charge précoce des urgences médicales courantes	14				

SECOURISME

I. DÉFINITION

Premiers gestes d'urgence pratiqués par des personnes formées pour apporter les soins initiaux à une vie en danger, avec ou sans matériel.

II. OBJECTIF DE LA FORMATION

À l'issue de la formation, le secouriste doit être capable de :

- Protéger la victime et les témoins.
- Alerter les secours adaptés.
- Empêcher l'aggravation de l'état de la victime jusqu'à l'arrivée des secours.

III. LES 3 RÈGLES D'OR (CHAÎNE DE SECOURS)

1. PROTÉGER
2. ALERTER
3. SECOURIR

Le témoin (vous) est le premier maillon de cette chaîne.

IV. ÉTAPE 1 : PROTÉGER

- Reconnaître les dangers : approche prudente, évaluer les risques (soi, victime, témoins), s'informer.
- Protéger : supprimer les dangers si possible, délimiter la zone.
- Dégager d'urgence (si danger persistant) : tirer par les chevilles/poignets, en priorité se protéger soi-même.
Techniques de transport si la victime peut marcher : portage à dos, dans les bras, "du pompier", à quatre mains ("la chaise"), à deux mains.
- Questions clés : incendie/explosion, effondrement, électrisation, asphyxie, noyade ?
- Cas particuliers :
 - Basse tension : couper le courant. Si impossible → ne pas toucher, alerter.
 - Haute tension : ne jamais toucher → alerter les secours spécialisés.
 - Atmosphère confinée : couper électricité/gaz, pas de flammes, ventiler, tirer la victime dehors.

V. ÉTAPE 2 : ALERTER

- Définition : informer un service d'urgence de la présence et de l'état des victimes.
- Quand : dès qu'il y a un risque ou une vie en danger.
- Moyens : téléphone (fixe, mobile, cabine).
- Qui : le sauveteur ou une tierce personne (donner les consignes).
- Numéros essentiels :
 - Sapeurs-pompiers : 14
 - SAMU : 15 (à vérifier selon pays)
 - Police : 1548
 - Gendarmerie : 1055
- Règles d'or (rapide et précise) :
 1. Lieu (atelier, étage, porte...)
 2. Nombre de victimes et leur état apparent
 3. Circonstances
 4. Ne jamais raccrocher la première : attendre les instructions.
 5. Envoyer quelqu'un au-devant des secours pour les guider.

VI. ÉTAPE 3 : SECOURIR

Gestes de base à connaître :

- Arrêter un saignement
- Protéger une plaie
- Prendre en charge une brûlure
- Massage cardiaque
- Libérer les voies aériennes et ventilation artificielle
- Position latérale de sécurité (PLS)
- Immobiliser un membre fracturé
- Relevage et brancardage

Priorité Niveau 1 : distinguer victime qui réagit vs victime qui ne réagit pas.

VII. CONDUITE À TENIR (RÉCAPITULATIF)

Situation	Action
Pas de danger	Alerter → Examiner → Secourir
Danger présent, victime déplaçable	Déplacer la victime → Alerter → Examiner → Secourir
Danger présent, victime non déplaçable	Alerter immédiatement

OBSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES CHEZ LE CONSCIENT

I. RECONNAÎTRE LA FAUSSE ROUTE (OBSTRUCTION TOTALE)

- Définition : Aucun passage d'air entre l'extérieur et les poumons
- Circonstances : Adulte qui mange /
Enfant qui joue avec petit objet
- Signes d'alerte :
 - Mains à la gorge
 - Bouche ouverte
 - Impossible de parler/tousser
 - Efforts respiratoires sans mouvement d'air
 - Se lève brusquement
- Risque : Mort rapide par manque d'oxygène

II. CONDUITE À TENIR

- Protocole : Alerter (Protection Civile 14)
→ Protéger → Secourir
- Gestes :
 - Victime dans sa position
 - 5 claques dans le dos
 - si inefficace :
5 compressions abdominales (Heimlich)
 - Alternier jusqu'à expulsion ou perte de connaissance

III. TECHNIQUES DE DÉSOBSTRUCTION

- Claques dans le dos (4-5) :
 - Victime penchée en avant (tête plus basse que les épaules)
 - coups secs entre les omoplates
- Heimlich :
 - Poing dans l'épigastre (au-dessus du nombril)
 - Poussée rapide vers le haut

IV. ÉVALUATION

- Efficace :
Expulsion, apparition de toux, reprise respiratoire
- Inefficace :
Répéter 5 claques / 5 Heimlich jusqu'à désobstruction ou perte de connaissance → alors RCP

V. CAS PARTICULIERS

- Nourrisson (< 1 an) :
Méthode de Mofenson
(PAS de compressions abdominales)
 1. 5 claques dans le dos (tête plus basse que thorax)
 2. 5 compressions thoraciques (2 doigts au sternum)
 3. Vérifier la bouche → retirer l'objet si visible
 4. Alternier jusqu'à expulsion, secours ou perte de connaissance

VI. OBSTRUCTION PARTIELLE

- Signes : Respire encore, tousse, parfois sifflement
- Conduite :
 - NE PAS faire claques ni Heimlich (risque de migration en totale)
 - Laisser en position confortable
 - Avis médical

VII. LIBÉRATION DES VOIES AÉRIENNES (sans corps étranger)

- Gestes :
 - Hyperextension du cou (basculer tête en arrière)
 - Subluxation de la mâchoire
 - Vérifier la bouche

VIII. VENTILATION

A. Bouche-à-bouche

- Tête inclinée en arrière
- Pincer le nez
- 4 insufflations complètes sans dégonfler entre elles

B. Bouche-à-nez

- Fermer la bouche de la victime
- Souffler dans le nez
- Même rythme

Technique	Position	Points clés
Bouche-à-bouche	Tête inclinée en arrière	Pincer le nez, 4 insufflations sans dégonfler
Bouche-à-nez	Tête inclinée en arrière	Fermer la bouche, souffler dans le nez

PATIENT INCONSCIENT : RESPIRATION OU ARRÊT RESPIRATOIRE

I. CONDUITE INITIALE

- Vérifier la conscience : parler fort, demander de serrer la main/ouvrir les yeux
- Vérifier la respiration : oreille près de bouche/nez → écouter, sentir, regarder le thorax

II. 2 CAS DE FIGURE

Cas	Situation	Conduite
1	Inconscient + NE respire pas	Arrêt cardio-respiratoire → RCP immédiate
2	Inconscient + respire	PLS + alerte + surveillance

III. CAS 1 – ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE (ACR)

Protéger (supprimer dangers) → Alerter (secours) → Secourir = ABC

Lettre	Signification	Action
A	<u>A</u> irway	Libérer les voies aériennes
B	<u>B</u> reathing	Bouche-à-bouche
C	<u>C</u> irculation	Compressions thoraciques ± défibrillation

A. RCP ADULTE

1. Position : sur le dos, sol dur, thorax nu
2. Massage : talon d'une main au centre du sternum, 2^e main dessus, bras tendus.
Pousser avec le poids du corps.

Profondeur 5-6 cm	Fréquence 100-120/min	Temps compression = relâchement
----------------------	--------------------------	------------------------------------

3. Bouche-à-bouche : 2 insufflations (1s chacune) après 30 compressions → rapport 30:2
4. Défibrillation (DSA/DEA) :
 - avant choc → thorax sec, personne au sec.
 - après choc → 2 min RCP sans vérifier le rythme
5. Arrêt RCP : uniquement à l'arrivée des secours

IV. CAS 2 – INCONSCIENT QUI RESPIRE

Alerter → Protéger (dangers, vomissements) → PLS

A. PLS (POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ)

1. Pourquoi ?

- Libérer voies aériennes
- Éviter inhalation vomissements/salive
- Maintenir respiration

2. Étapes clés :

- dégrafer col/ceinture
- bras côté retournement à 90°, paume vers haut
- main du sauveteur contre paume victime, dos de la main contre joue
- saisir creux poplité jambe opposée
- faire pivoter
- cuisse à 90° (béquille)
- ouvrir la bouche

3. Surveillance : vérifier respiration toutes les minutes

V. PARTICULARITÉS

Situation	Conduite
Nourrisson (seul)	Compressions avec 2 doigts
Nourrisson (plusieurs)	Compressions avec 2 pouces encerclant
Enfant prépubère (plusieurs)	Rapport 15:2
> 1 an	DEA recommandé
Femme enceinte/obèse	PLS sur le côté gauche
Convulsion	PLS après la crise

VI. ⚠ CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- X Arrêter la RCP avant les secours
- X Masser avec les bras seulement (utiliser le poids du corps)
- X Oublier de vérifier la respiration chez un inconscient qui respire